INTUBATION EN VENTILATION SPONTANÉE

SI DYSPNEE LARYNGEE : envisager une TRACHEOTOMIE SOUS AL

CRITÈRES D'INTUBATION EN VS (liste non exhaustive)
= intubation et ventilation jugées impossibles sous AG

- ❑ Ouverture de bouche < 25mm (tester passage de lame du laryngo)
- ❑ Rachis bloqué en flexion
- ❑ Pathologie cervico-faciale (voir TDM +/- naso-fibroscopie)
- ❑ ATCD de radiothérapie cervicale ou de chirurgie des VAS
- ❑ Risque d'obstruction des VAS

CHOIX DE LA TECHNIQUE

- ❑ FIBROSCOPIE EN VS :
  - Technique de référence
  - INT plus facile que IOT
- ❑ VIDÉOLARYNGOSCOPIE EN VS si :
  - Ouverture de bouche suffisante
  - Opérateur entraîné
  - Fibroscope disponible

Etape 1 : ANTICIPATION DES DIFFICULTÉS

- ❑ INFORMATION DU PATIENT :
  - Déroulé de chaque étape de l'intubation, réassurance, obtenir la coopération du patient
- ❑ PRÉPARATION DU GESTE :
  - Evaluation des VAS et du diamètre de la trachée (TDM), repérage membrane crico-thyroïdienne (écho)
  - Vérification du matériel d'intubation : fibroscope, aspiration, diamètre de sonde adapté, lubrification
  - Disponibilité du chariot d'urgence vitale
  - +/- Chirurgien en salle avec matériel de trachéotomie
- ❑ BRIEFING D'ÉQUIPE :
  - Anticiper le personnel nécessaire en salle et identifier les renforts possibles
  - Enoncer clairement la stratégie et la répartition des rôles

Etape 2 : ANESTHÉSIE LOCALE ÉTAGÉE

- ❑ INSTALLATION DU PATIENT au calme, monitorage, pose de VVP
- ❑ ANESTHÉSIE LOCALE (au moins 30 minutes avant l'intubation) :
  - AL progressive et séquencée : fosses nasales, oropharynx, larynx, trachée
  - Par **lidocaïne** (spray, gargarisme, aérosol), **lidocaïne naphazolinée** (méchage nasal)

Dose **MAXIMALE** de lidocaïne : **4 à 6mg/kg**
(cf verso)

Etape 3 : OXYGÉNATION, RÉALISATION DU GESTE

- ❑ ENVIRONNEMENT CALME au bloc opératoire : « silent cockpit », communication positive, réassurance du patient
- ❑ INSTALLATION DU PATIENT en position ½ assise (fibroscopie) ou allongée (vidéolaryngoscopie)
- ❑ **OXYGÉNATION CONTINUE** (objectif SpO_2 > 98%) :
  - Oxygénation nasale à haut débit ONHD (débit 50L/min, FiO_2 100%)
  - A défaut : masque à haute concentration (débit 12 à 15L/min)
- ❑ SÉDATION en VS :
  - **AIVOC propofol** seul ou **AIVOC remifentanil** seul, augmenter la cible par palier
  - Objectifs : maintien de la VS et de la coopération du patient, confort du patient
- ❑ EXPOSITION glottique progressive par fibroscopie ou vidéolaryngoscopie (complément d'AL si nécessaire)
- ❑ INSERTION de la sonde d'intubation dans la trachée
- ❑ **DOUBLE CONTRÔLE VISUEL** : position intra-trachéale de la sonde d'intubation + présence d'une courbe d'$EtCO_2$ (⚠ seul ce double contrôle visuel autorise la sédation en apnée)

- ❑ INDUCTION de la SÉDATION EN APNÉE
- ❑ Garder une ATTENTION CONSTANTE lors de l'installation du patient (période à risque d'extubation)

TSVP

Etape 4 : GESTION DES DIFFICULTÉS

DÉSATURATION

- ❑ Si patient en VS : augmenter le débit d'O_2, introduire l'ONHD
- ❑ Si patient en apnée : baisser l'AIVOC, subluxer la mandibule, stimuler le patient
- ❑ Si $SpO_2 < 90\%$: arrêter le geste, restaurer l'oxygénation (+/- dispositif supraglottique, cricothyroïdotomie SMS)
- ❑ Si apparition d'une dyspnée laryngée STOP : envisager une trachéotomie sous AL

SÉDATION INADAPTÉE

- ❑ Insuffisante : compléter l'AL, augmenter l'AIVOC par paliers prudents (⚠ CI bolus de propofol)
- ❑ Trop profonde (⚠ risque d'apnée / obstruction VAS) : baisser l'AIVOC, subluxer la mandibule, stimuler le patient

ÉCHEC D'INTUBATION EN VS

- ❑ Si chirurgie non urgente : reporter l'intervention, réévaluation collégiale de la stratégie anesthésique
- ❑ Si chirurgie urgente : appel du chirurgien pour envisager une trachéotomie sous AL

Etape 5 : APRÈS LA CHIRURGIE

- ❑ Si extubation à risque : RESTER VIGILANT, adapter les moyens humains et matériels
- ❑ ÉVALUATION DU VÉCU du patient en SSPI (« defusing »)
- ❑ TEST DE LA DÉGLUTITION avant reprise de l'alimentation solide et liquide
- ❑ DÉBRIEFING en équipe
- ❑ SUIVI PSYCHOLOGIQUE du patient si vécu négatif, ou SUIVI SPECIALISÉ si signes d'ESPT à distance

Précautions pour l'ANESTHÉSIE LOCALE DES VAS :

- Dose maximale de lidocaïne : 6mg/kg chez l'adulte,
  4mg/kg si insuffisance rénale et hépatique, sujet âgé, dénutrition.
- Lidocaïne 5% (spray ou nébuliseur) : 1 spray = 8mg de lidocaïne.
- Lidocaïne 10mg/mL : instillation par le canal opérateur du fibroscope (⚠ absorption plasmatique majorée par les muqueuses de l'arbre bronchique).
- Limiter l'utilisation d'AL durant la chirurgie : calculer la dose totale administrée.

Vidéo pédagogique : Fibroguidage

Vidéo pédagogique : Vidéolaryngoscope

Références : RFE SFAR 2026 "Prise en charge initiale des voies aériennes de l'adulte au bloc opératoire"

Réalisée en 2021 et mise à jour en 2026 par le CAMR